

ПРАКТИЧНА СТАНЦІЯ

«Вузловий токсичний зоб»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Провести поверхневу пальпацію щитовидної залози.
- Оцінити поверхневу пальпацію щитовидної залози.
- Оцінити результат аналізу крові на гормони щитовидної залози (тиреоїдна панель)
- Оцінити УЗД щитовидної залози.
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні сценарії, які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

Ви лікар-терапевт. На прийомі - жінка 47 років, вчитель.

Скарги: на тремор рук, перебої в роботі серця, серцебиття, загальну слабкість, нервозність, порушення менструального циклу.

Анамнез захворювання: вказані скарги відмічає близько 4-5 місяців, до теперішнього часу не обстежувалася. Самостійно лікарські препарати не приймає.

Об'єктивно: стан відносно задовільний. Шкіра та видимі слизові оболонки блідо-рожеві, чисті, сухі. Периферичних набряків немає. У легенях – везикулярне дихання, ЧДД=17 в 1 хвилину. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця звучні, фібриляція передсердь. ЧСС=106 за хв. Пульс=100 за хв. Дефіцит пульсу = 6 за хв. АТ_{на обох руках} - 115/80 мм рт.ст. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додаток 1 Характеристика щитовидної залози

Температура шкіри над залозою не підвищена, щитоподібна залоза збільшена до 2 ст., безболісна, консистенція ущільнена, справа пальпується два безболісних вузла (6x10 мм, 4x6 мм), зліва- один вузол (20x28 мм), судинної пульсації і тремтіння не виявлено.

Додаток 2.Тиреоїдна панель

Показник	Результат	Референтний інтервал
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)	11.14 пмоль/л	Дорослі: 3.1-6.8
Тироксин вільний (Т4 вільний)	29.55 пмоль/л	Дорослі: 12.0-22.0
Тиреотропний гормон (ТТГ)	0.09мкМО/мл	Дорослі: 0.27-4.2
Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО)	14.20 МО/мл	до 34.0

Додаток 3. Ультразвукове дослідження щитовидної залози



Заключення. Щитоподібна залоза розташована в типовому місці, контури нерівні, чіткі. Капсула потовщена, залоза рухлива. Структура неоднорідна, середньокмірчаста за рахунок гіпоехогенних ділянок, гіперехогенних ділянок з обох сторін. У правій частці візуалізується рідинно-тканеві утворення 6x10, 4x6 мм, колоїдні утворення 3 мм та 4 мм. У лівій частці візуалізується ізоехогенне утворення 20x28 мм, включення: мікрокальцинати. Обсяг правої частки – 3,91 см³, перешийок – 4 мм, обсяг лівої частки – 8,65 см³, загальний об'єм – 12,56 см³ (норма 11,5 см³).

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції.

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>	Форма представлення
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
	інформовану згоду отримано;	Сказати
	обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.	Виконати
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ПОВЕРХНЕВА ПАЛЬПАЦІЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ»:		
	Ліва рука укладається ззаду на шию пацієнта з метою фіксації тіла і голови - великий палець на передній поверхні ший, інші пальці на задній поверхні ший.	

	Права рука лікаря укладається на область щитовидної залози - від середини щитовидного хряща вниз, і ковзаючим рухом обмацує передню поверхню шийї до яремної вирізки.	Виконати
	Перекочуючись кінчиками пальців через перешийок, визначає його ширину, консистенцію, рухливість при ковтанні. Після цього в борознах, утворених бічними поверхнями щитовидного хряща і внутрішніми краями кивальних м'язів, безпосередньо над верхнім краєм перешийка намагаємося намацати бічні частки залози. Пальпують зімкнутими кінчиками вказівного, середнього та безіменного пальців правої руки спочатку з одного боку, а потім - з іншого. Напрямок пальпації - від щитовидного хряща до кивального м'яза	
	Визначити характеристики щитовидної залози: • температуру шкіри над залозою; • орієнтовну величину залози, її часток; • характер поверхні залози; • щільність органу; • наявність великих вузлів; • наявність судинної пульсації і тремтіння; • болючість залози	Сказати
	Самопочуття пацієнта задовільне	Сказати
ДІАГНОСТИКА:		
Оцінити поверхневу пальпацію щитовидної залози (Додаток 1)	Температура шкіри над залозою не підвищена, щитоподібна залоза збільшена до 2 ст., безболісна, консистенція ущільнена, справа пальпується два безболісних вузла (6х10 мм, 4х6 мм), зліва- один вузол (20х28 мм), що може свідчити про наявність у хворої вузлового зобу.	Сказати/записати в історію хвороби
Оцінити результат аналізу крові на гормони щитовидної залози (тиреоїдна панель) (Додаток 3)	Пригнічення секреції ТТГ та виражене підвищення рівнів FT4 і FT3 свідчить про гіперфункцію щитовидної залози.	Сказати/записати в історію хвороби
Оцінити УЗД щитовидної залози(Додаток 3)	УЗД-картина щитовидної залози свідчить про багатовузловий зоб на фоні патології щитовидної залози.	Сказати/записати в історію хвороби

<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Вузловий токсичний зоб	Сказати/записати в історію хвороби
4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ		
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Госпіталізація для подальшого обстеження та підбору оптимальної терапії. Розглянути необхідність оперативного лікування Тиреостатичні препарати β-блокатори	Сказати/записати в історію хвороби
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:		
	Уникати сонячного випромінювання. Контролювати рівень гормонів кожні 6 тижнів до досягнення еутиреозу Контролювати УЗД щитовидної залози кожні 6 місяців.	Сказати/записати в історію хвороби